Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Mateo Alonso Erazo Guevara				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	01/04/2012	Edad actual	13 años	11 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Los Senderos, Diputado Genesto Igle 1452				Teléfono	66672373	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☐				
Escolaridad actual:	8° B	Establecimiento	Liceo nuevo Basico 2				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 25/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Diana Guevara	Nombre:
Relación con el/la estudiante: mamá	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 25/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Ithanio Barraza	Nombre:
Rol/cargo: Ed Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso al programa de Integración

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro: No Recuerdo con exactitud Diagnostico pero estuvo en PIE

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☑ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO	Peso: 2.870	Talla: 48.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Madre no se dilataba y a Mateo le bajaron los latidos, al nacer no se lo entregaron altiro, si no que después de 40 minutos porque estaba morado. Lactancia duró menos de un mes

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Si	~~No~~	Traumatismos	Si	~~No~~	Encefalitis	Si	~~No~~
Obesidad	Si	~~No~~	Intoxicación	Si	~~No~~	Meningitis	Si	~~No~~
Fiebre alta	Si	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Si	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Si	~~No~~	Asma	Si	~~No~~			
Hospitalizaciones	~~Si~~	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Si~~	No		Vacunas	~~Si~~ No

Observaciones:
A los 4 días lo hospitalizaron porque el color de sus fecas era extraño y le dijeron que tenía una infección y estuvo 2 semanas hospitalizado.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza:	Se sienta sólo/a:	Camina sin apoyo:
Primeras palabras:	Primeras frases:	Se viste solo/a:
Controla esfínter vesical Diurno: _____ Nocturno:_____	Controla esfínter anal Diurno: _____ Nocturno:_____	

Observaciones:
NO Recuerdo los meses exactos, pero todo se desarrolló dentro de lo normal

En su actividad motora general se aprecia:
☐ normal ☐ activo ☑ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☐ normal ☑ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Si~~	No	Caídas frecuentes	Si	~~No~~	Dominancia lateral	~~Si~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Si	No	Prensión	Si	No	Pinza	Si	No
Ensarta	Si	~~No~~	Dibuja	Si	~~No~~	Escribe	~~Si~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Si~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Si~~	No
Demanda objetos y compañía	Si	~~No~~	Comprende prohibiciones	~~Si~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Si~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones:
De pequeño tuvo problema de motricidad fino y gruesa.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Si	~~No~~	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	~~Si~~	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Si	~~No~~	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Si~~	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	~~Si~~	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Si~~	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Si	~~No~~	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Si	~~No~~
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	~~Si~~	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Si	~~No~~
Presenta movimientos oculares "anormales"	Si	~~No~~	Presenta frecuentes dolores de oídos	Si	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Si	~~No~~	La pronunciación oral es adecuada	~~Si~~	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Si	~~No~~	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Si	~~No~~

Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☑ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO

Observaciones:

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
Estudiante le ha manifestado a mama que le duelen mucho las rodillas.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☑ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 6 a 7 hrs.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor	Duerme: ☑ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento (señale el comportamiento habitual)

☐ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☑ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Diana Guevara	Mamá	38	Sup Incom	Trabajador Dependiente
2. Amelie Evaro	hermana	15	1° Medio	Estudiante
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Sin antecedente de salud importante.

Observaciones:

Padres separados, pero re fin de semana por medio el papá.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar											
Edad de ingreso al sistema escolar	5			Asistió a jardín infantil			Sí	No			
N° de colegios en que ha estudiado	3			Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:							
Motivo de los cambios: Por cambios de domicilio											
Ha repetido curso/s	Sí X		No	Curso(s) 1° básico		Motivo: Por bajo rendimiento					
Situación actual											
Nivel/curso actual	8vo			**Dificultad de aprendizaje**	Sí X	No	**Dificultad para participar**	Sí	No X	**Conducta disruptiva**	Sí	No X
Asiste regularmente	Sí	No X		Asiste con agrado	Sí	No X	Apoyo familiar en tareas	Sí X	No	Amigos (as)	Sí X	No
Actitud de la familia											
¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante? ☒ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos)											
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante? ☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra											
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante? ☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ..... Especifique el tipo de refuerzos o premios: ☒ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....											
¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante? ☒ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales											
¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante? ☒ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)											
¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?											

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Nateo desde kinder tuvo problemas de motricidad fina, con el agarre.
Estuvo en PIE en colegio Santa María de Icongagua en Santa María. (no recuerdo diagnostico, ni año.)
A los 5 años lo llevé al neurólogo y le dieron ritalín, pero mamá no le siguió dando el medicamento

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY